

Introducción

La educación en Cuba a partir del triunfo revolucionario es tratada como una prioridad para el pueblo. Desde sus primeros momentos se tomaron medidas en la solución a las problemáticas existentes. Inicialmente se realiza la Campaña de alfabetización, la Campaña por el sexto grado, la enseñanza se hizo gratuita, se nacionalizaron las escuelas y comenzó la capacitación político-ideológica y cultural del pueblo en la que se trabajó con mucho vigor.

Desde 1959 el Ministerio de Educación se plantea la necesidad de crear el departamento de Educación Especial con la Sección de Sordomudos; lo cual constituye una pauta importante en la Logopedia. A pesar de que existían en el sector de salud consultas a pacientes con trastornos de fluencia verbal y otros más complejos, no era suficiente el personal capacitado para suplir las demandas de la población. Es entonces cuando comienza la preparación en la década del 60 de logopediatras educacionales (maestros terapeutas) y posteriormente los logopedas defectólogos que atendían desde las escuelas los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Toda una ardua labor que permite hoy en día a los niños la atención a los trastornos del lenguaje en escuelas tanto de enseñanza especial como general con docentes, especialistas y condiciones indispensables para una atención integral.

La creación masiva de escuelas especiales el 31 de diciembre de 1989 fue un paso trascendental en la historia de este sector. La labor desarrollada por el gobierno cubano en conjunto con organizaciones políticas y educativas mantiene su actualidad de forma tal que existen centros referenciales que ayudan a los niños con necesidades especiales asociadas o no a discapacidad.

En este sentido y en aras de mejorarla calidad del sistema educativo se aboga por la inclusión. Los niños y sus familias gozan de derechos a una atención especializada y diferenciada que responda a un enfoque humanista con educación para todos. Desde el punto de vista teórico y práctico la escuela debe dar respuesta a la diversidad a través de acciones concretas, actitudes y valores.

A pesar de ello existen deficiencias en la práctica. La falta de maestros y auxiliares, altas matrículas de escolares en el grupo, escasos recursos materiales y tecnológicos, entre otros son factores que dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje para la inclusión educativa en la escuela primaria.

El **objetivo** propuesto con esta investigación es sugerir un sistema de tratamientos logopédicos para un niño con retraso del lenguaje asociado a Retardo en el desarrollo psíquico incluido en la escuela primaria. Es por ello que se realizó una caracterización del nivel de desarrollo de habilidades cognoscitivas y comunicativas alcanzado por el educando, lo cual determina las potencialidades y necesidades para conocer las causas biológicas y sociales del problema existente; y así proponer la estrategia de intervención para los maestros y la familia.

Desarrollo

Fundamentación teórica metodológica para el estudio de caso de un niño que presenta un retraso del lenguaje asociado a un retardo en el desarrollo psíquico

La adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el desarrollo del ser humano, ya que de él depende el correcto funcionamiento de otras áreas como la cognitiva, la afectiva-volitiva y los procesos de autorregulación de la conducta. Para ello se hace necesaria una estimulación temprana del lenguaje, mediante la interacción y el juego, lo que permite desarrollar destrezas visuales, auditivas, táctiles, motrices, cognitivas, sociales entre otras.

En el desarrollo evolutivo del lenguaje se distinguen generalmente tres etapas o fases fundamentales: pre lenguaje, primer lenguaje y lenguaje propiamente dicho, en estas etapas los niños van apropiando de los medios expresivos que el lenguaje le proporciona, por ejemplo:

Etapa pre lenguaje

- 0 - 6 meses: Lo primero que aparece es el grito al nacer. Durante el primer mes, dicho grito se transforma en un grito emocional. Esto ya se considera una forma de lenguaje pues hace que los demás intervengan. Desde el primer momento se debe hablar a los bebés, hacemos entender, interactuar con el lactante puesto que la interacción madre-bebé es primordial para su desarrollo normal. El bebé aprende los primeros sonidos vocalizados. Hacia los cuatro-cinco meses se inicia el balbuceo, rico y melódico.
- 7 - 11 meses: El niño escucha mucho y repite, es lo que denominar "ecolalia". Juega con los sonidos, disfruta produciendo sonidos. Responde al oír su nombre. A partir de los siete meses inhibe más el balbuceo, Habla menos y por eso lo llamamos "Mutismo". La primera palabra puede pronunciarse a los 8 meses, aunque por lo general ocurre alrededor del año o un poquito más allá.

Etapa primer lenguaje

- 12 - 18 meses: Es la etapa de las palabras.
- 18 - 24 meses: Ya es capaz de decir frases de dos palabras. Para el niño esto es una frase.
- 24 - 36 meses: Estadio de formación gramatical.

El tiempo que transcurre entre la primera palabra y las primeras frases es muy importante para evaluar un posible retraso del lenguaje.

Etapa de lenguaje propiamente dicho

- 3 años: Es capaz de decir “Yo”. Su lenguaje hablado es bastante correcto. Muchos niños en esta edad tartamudean, esto es normal. Ésta es la época en que se lanzan a hablar y es común un desequilibrio entre las ideas que desea expresar y las posibilidades que tiene desde el punto de vista neurolingüística, que todavía no son suficientes, por este motivo se producen elongaciones de sonidos, repeticiones de sonidos y sílabas, titubeos y atropellos de algunos elementos de la frase cuando logran salir del tartamudeo.

En este período no se hacen exigencias articulatorias, no se intenta perfeccionar el lenguaje; la familia debe continuar estimulando su desarrollo y rodear al niño de un ambiente emocional de distensión, tranquilidad y comprensión, estas manifestaciones pueden durar algún tiempo, luego desaparecen sin dejar secuelas. El incumplimiento de las medidas antes mencionadas pudiera complejizar este proceso fisiológico y comprometer la fluidez verbal del niño, aparecerían contracciones o bloqueos respiratorios, fonatorios y articulatorios como expresión de una tartamudez inicial.

- 3 - 5 años: Progresan las construcciones gramaticales. Es la época de la verdadera comunicación.
- 5 años y medio: A partir de esta edad el niño asume ya un lenguaje correcto, están presentes todos los sonidos del idioma, solo algunos casos se perfecciona el uso de palabras con sílabas directas dobles y la conjugación de los verbos irregulares

Sin embargo, existen varios factores que influyen de manera negativa y provocan retrasos en el lenguaje por ejemplo la poca estimulación en el período sensitivo, imitación de patrones lingüísticos incorrectos; también se producen trastornos que se consideran secundarios por una afectación biológica, entre otras causas.

En el contexto internacional los estudios de Gallego Ortega (2003) refieren que el lenguaje no aparece a la edad en la cual normalmente debe presentarse, la permanencia de patrones lingüísticos que corresponden a estadios anteriores a los que, por su edad cronológica, le corresponderían al niño; y todos los componentes del lenguaje están o pueden estar afectados en mayor o menor grado. Los retrasos del lenguaje reúnen a un grupo muy heterogéneo de sujetos que presentan alteraciones en algunos o en todos los componentes del sistema lingüístico.

Otro de los criterios que deben considerarse son los que indican en el DSM IV (manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales) dentro de los trastornos de la infancia y refiriéndose a los de la comunicación, se incluyen los del lenguaje expresivo, los trastornos del lenguaje receptivo-expresivo y los

trastornos fonológicos. El trastorno puede manifestarse a través de varios síntomas que incluye un vocabulario sumamente limitado, comete errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la memorización de palabras o en la producción de frases.

Cabe destacar la labor realizada en Cuba por numerosos autores en investigaciones sobre el retraso del lenguaje; tal es el caso de López, M. (1997) la cual considera que un niño está retrasado en el lenguaje cuando desde el punto de vista cuantitativo (cantidad de vocabulario) y cualitativo (diferentes áreas del lenguaje) está por debajo de la cifra media de los niños de su edad.¹

Por otra parte consideran que es un Rodríguez, X. y Díaz, M. L. (2008) “[...] trastorno del lenguaje que afecta la formación y desarrollo de sus componentes estructurales (fonología, semántica, sintaxis) relacionados con los mecanismos de recepción y programación lingüística”²

Autores como Cabanas, R. (1998), Fernández, G. (2012), plantean (...) “es un retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático) que afecta la expresión y en menor medida la comprensión, sin que esto se deba a un trastorno generalizado del desarrollo, ni a déficit auditivo o trastorno neurológico. La aparición del lenguaje y la expresión es más tardía de lo habitual y se desarrolla lenta y desfasadamente con respecto a lo que cabe esperar de un niño de esa edad cronológica”.

El concepto anteriormente expuesto es el más aceptado para la investigación por su actualidad y su relación con el estudio de este caso. Además, tiene en cuenta los componentes del lenguaje para el diagnóstico.

Los criterios de clasificación del trastorno según los autores varían desde diferentes puntos de vista. En este estudio de caso se asumen: retraso específico severo del lenguaje y retraso simple del lenguaje.

¹ López, M.: El lenguaje infantil. Editorial Científico-Técnica. Ciudad de la Habana, 1997. p. 26

² Rodríguez, X. y Díaz M.: Los retardos del lenguaje en la educación infantil. Su caracterización e intervención logopédica. Material de apoyo a la docencia. UCP “Enrique José Varona”. En soporte digital, 2008. p.7

“El retraso específico severo del lenguaje es considerado la manifestación más grave de presentación del trastorno. Hay una ausencia total o casi total de comunicación empleando el lenguaje articulado. Están afectados casi todos los sonidos del idioma, se acompaña de un significativo retraso en el desarrollo del vocabulario, utilizan palabras fuera del contexto y mal estructuradas desde el punto de vista silábico y sonidos onomatopéyicos; por lo general se acompaña de un lenguaje extra verbal compuesto por mímica, gestos y señas. En el caso de retraso simple del lenguaje es menor la dificultad en los componentes fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático, pero permanecen las insuficiencias en el área del lenguaje en cuanto a vocabulario, expresión, lógica de ideas, etcétera”.³

Esta denominación engloba a aquellos niños que manifiestan, tanto en su expresión como en su comprensión, un cierto desfase cronológico en el desarrollo del lenguaje, sin que se adviertan alteraciones mentales, sensoriales, motrices y relacionales. Este tipo de retraso se caracteriza según Cano, M.I. y Navarro M: I (2003) por:

-Alteraciones fonológicas.

-Alteraciones en la concordancia.

-Léxico pobre e impreciso en algunas ocasiones, pero con recursos para resolver sus dificultades.

-Sintaxis simple para su edad.

-La comprensión es superior a la expresión, pero inferior a su grupo normativo.

-En tareas de repetición de oraciones simplifica las palabras más largas y complejas.

A nivel fonológico se advierte una tendencia a los procesos de simplificación del habla, principalmente en los grupos consonánticos, del tipo CCV (consonante+ consonante+ vocal) y de los diptongos vocálicos.

³Fernández, G. Logopedia II. Ed. Pueblo y Educación, 2012.

A nivel morfosintáctico podría hablarse como recoge Aguado (1988) y Gallardo (2003), que existe cierta normalidad en las emisiones, las formas verbales son las adecuadas, a veces las concordancias están bien realizadas y utilizan las preposiciones, las conjunciones y los adverbios, mantienen la estructura de frase dependiendo de la edad, pero no siempre ocurre así, hay cierta inconsistencia.

De todos modos, según la mayoría de los autores, en el retraso simple ocurre que:

- La aparición de las primeras palabras se retrasa hasta los dos años.

- La unión de dos palabras no aparece hasta los tres años.

- Uso de frases sencillas, palabras yuxtapuestas sin empleo de nexos, rellenando los espacios vacíos con sonidos indescifrables, que dan la sensación de frases largas.

- Vocabulario limitado y abundante presencia de expresiones telegráfica.

- Dificultades en la comprensión y en la expresión, aunque la comprensión pudiera aparecer como "normal".

En la siguiente investigación el retraso del lenguaje se manifiesta en un niño que presenta Retardo en el Desarrollo Psíquico. La categoría "retardo en el desarrollo psíquico" posee diferentes denominaciones, tales como: retardo del desarrollo intelectual, ritmo lento del desarrollo, retraso en el desarrollo, disfunción cerebral mínima y otros. El término "retardo" subraya lo transitorio (falta de correspondencia entre el nivel del desarrollo psíquico y la edad) y al mismo tiempo este carácter transitorio del atraso se supera con la edad, cuanto más temprana y adecuadamente se creen las condiciones de enseñanza y aprendizaje para los niños que pertenecen a este grupo diagnóstico.

El carácter transitorio del retardo se refiere a que con la edad, que implica maduración de los sistemas funcionales y con las ayudas tempranas y oportunas, se logra satisfacer las necesidades de su desarrollo. Las investigaciones de Torres González M., Domishkievich S., y Herrera L. F. (1991) reflejan una perspectiva optimista al definir el retardo en el desarrollo

psíquico “como una de las variantes del trastorno en el curso normal del desarrollo psíquico caracterizado por un ritmo lento de la formación de las esferas cognitiva y emotivo volitiva, las que se quedan temporalmente en períodos etéreos más tempranos”⁴.

Lebedinskaya K. (1989) ofrece la clasificación etiopatogénica del retardo en el desarrollo psíquico, donde las principales formas clínicas se diferencian por el principio etiopatogénico: de procedencia constitucional, somatógena, psicógena, cerebroasténica. Todas estas variantes de retardo en el desarrollo psíquico se diferencian por las peculiaridades de la estructura y por el carácter de relaciones entre dos principales componentes: por estructura del infantilismo y por el carácter de las relaciones neurodinámicas.

Retardo en el desarrollo psíquico de procedencia constitucional (infantilismo armónico): se caracteriza por el nivel más bajo del desarrollo de la esfera emocional-volitiva comparada con la estructura emocional de los niños de edad escolar primaria, donde predomina la motivación emocional de la conducta, aumento del estado de ánimo, espontaneidad, vivacidad de emociones, aunque ellos adquieren el carácter superficial e inestable, facilidad de sugestión. Las dificultades en el aprendizaje que se observan en los niños de grados inferiores están relacionadas con poca madurez de la esfera motivacional y de la personalidad en general, predominan los intereses lúdicos.

Retardo en el desarrollo psíquico de procedencia somatógena: está condicionado por prolongada insuficiencia somática como: infecciones crónicas, estados alérgicos, defectos congénitos o adquiridos del desarrollo de la esfera somática, por ejemplo, del corazón, neurosis infantiles y astenia. Estas causas pueden llevar hacia la disminución del tono psíquico, el retardo del desarrollo emocional-*infantilismo somatógeno*, condicionado por una serie de síntomas neuróticos-inseguridad y temor, relacionados con la sensación de sus propias dificultades o a veces provocada por el régimen de prohibiciones y limitaciones, en el cual se encuentra el niño debilitado. Se alteran las relaciones interpersonales.

Retardo en el desarrollo psíquico de procedencia psicógena está relacionado con las condiciones desfavorables de educación, que impiden la correcta formación de la personalidad del niño. Las condiciones desfavorables del entorno, surgidas

⁴Torres González M., Domishkievich S., y Herrera L. F. retardo en el desarrollo psíquico. Ed. Pueblo y Educación. La Habana, 1991, p. 23.

tempranamente que influyen negativamente en la psiquis, pueden conducir hacia cambios estables de su esfera neuropsicológica, provocar trastornos de las funciones vegetativas y psíquicas, en primer lugar del desarrollo emocional.

Retardo en el desarrollo psíquico de procedencia cerebroasténica: se caracteriza por la presencia de la lesión orgánica del sistema nervioso central de carácter residual, no conduce hacia trastornos estables de la actividad cognoscitiva. Los estudios anamnésicos de los niños que pertenecen a este grupo en la mayoría de los casos demuestran insuficiencia orgánica de carácter residual como consecuencia de patologías durante el embarazo: toxicosis graves, infecciones, intoxicaciones, traumas, Rhesus-factor, asfixias y traumas durante el parto. La insuficiencia cerebroasténica influye en la estructura del retardo en el desarrollo psíquico, provoca inmadurez emocional y determina el carácter de los trastornos de la actividad cognoscitiva.

Es necesario aclarar que el estado asténico como resultado de cualquier enfermedad por sí mismo no constituye una forma de disontogénesis, a pesar de que en él pueden observarse los retrocesos en el desarrollo psíquico, pérdida temporal de los hábitos anteriormente adquiridos. Si estos eventos tienen un carácter situacional, reversible, si no retardan el paso del niño al siguiente período de desarrollo psicológico, entonces no se consideran como trastornos del desarrollo.

La estructura del defecto en el retardo en el desarrollo psíquico se puede determinar tanto en la edad preescolar y escolar, pues en estos períodos etáreos comienzan a observarse las insuficiencias en los componentes intelectuales y reguladores de la actividad. Desde la edad preescolar se observan las manifestaciones del ligero retardo en la formación de las distintas funciones psíquicas: motricidad, funciones perceptivas, lenguaje, así como en la inmadurez de las reacciones afectivas.

Hacia la edad escolar se retarda el ritmo de desarrollo de la actividad cognoscitiva, en la cual surgen dificultades durante la ejecución de las tareas docentes. Este período del desarrollo se caracteriza por el ritmo lento en el desarrollo psíquico de forma temporal, fundamentalmente de las funciones cognoscitivas superiores y de la esfera emotiva - volitiva, y las insuficiencias en las operaciones lógicas del pensamiento no son severas (el análisis, la síntesis,

la abstracción, la comparación y la generalización, en especial el nivel lógico verbal.

El ritmo lento del desarrollo de las funciones cognoscitivas superiores y de la esfera emocional-volitiva posee un carácter temporal y resulta reversible, no existe pérdida de las funciones, están conservadas las interacciones interfuncionales.

Al igual que en otras formas de disontogénesis, los trastornos primarios reflejados en las alteraciones neuropsíquicas, la afectación de algunas funciones cortico-subcorticales producto de su carácter orgánico residual, no son completamente superables, aunque no entorpecen el desarrollo del sujeto y con una enseñanza especialmente organizada, se logra el desarrollo multilateral de las estructuras psicológicas superiores que constituyen el pensamiento abstracto, los sentimientos superiores, la voluntad y las formaciones complejas de la personalidad, cuyo desarrollo en gran medida compensa la manifestación de las dificultades neuropsíquicas que quedan como secuela.

Siguiendo la idea de L.S. Vigotsky acerca de que es incorrecto extraer todos los síntomas, todas las características psicológicas de la “desviación” a partir de la lesión del cerebro, por cuanto, conjuntamente con el factor de la lesión está también el factor del desarrollo, en el curso del desarrollo del retardo, los síntomas primarios cambian su papel y significado, sobre su base pueden surgir las manifestaciones, características para una determinada edad concreta.

L.S. Vigotsky (1983) señalaba: “Todos los síntomas no se presentan en una fila, cuyos miembros se encuentran con actitudes completamente idénticas ante la causa, engendradas por toda la fila”, lo que se corresponde con la estructura dinámica de los sistemas funcionales que no poseen alteraciones. Los trastornos secundarios se van construyendo o formando a partir de la interacción entre el defecto nuclear de base o primario y sus condiciones ambientales, entre este defecto y la cultura, están condicionados por factores sociales, por la relación del niño con el medio social, donde vive y se desarrolla.

Las insuficiencias en el desarrollo de las funciones psíquicas superiores, y las alteraciones en la esfera emocional-volitiva son desviaciones secundarias en el

caso del retardo en el desarrollo psíquico, pero a diferencia del retraso mental, no poseen un carácter generalizado y total.

La tendencia de la compensación del defecto en la edad infantil posee una doble determinación: en primer lugar, la tendencia natural del organismo como sistema de autorregulación en el restablecimiento de las funciones, y en segundo lugar, la misma situación social del desarrollo del niño, que conduce a la acción de las fuerzas motrices de su desarrollo psíquico.

El carácter orgánico o funcional del trastorno, así como su especificidad determinan la fuerza de la tendencia natural del organismo al restablecimiento de la función. Las condiciones materiales socio-psicológicas de la educación pueden reafirmar o limitar esta tendencia de manera significativa. Ellas pueden sustentar la intención del niño hacia la actividad, formar en él las necesidades de elevar el conocimiento sobre el medio, de la comunicación con las personas, reafirmar el deseo de dominar hábitos y habilidades. En este sentido, las regularidades del desarrollo del niño con retardo en el desarrollo psíquico deben superar determinadas barreras en su desarrollo. El retardo en el desarrollo de algunas de las funciones psíquicas superiores y la evolución adecuada de otras brindan las posibilidades reales de reversibilidad de las funciones afectadas.

Las desviaciones terciarias en el retardo en el desarrollo psíquico se manifiestan en el carácter disarmónico de la personalidad, en forma de inmadurez, pero solamente en algunos de sus componentes, no se afecta toda la estructura de la personalidad.

El retardo en el ritmo del desarrollo intelectual crea algunas premisas para el desarrollo disarmónico de la personalidad, fundamentalmente debido a la inadaptación a las condiciones de la actividad docente, pero en la eliminación de esta inadaptación se conserva la posibilidad de la corrección, tanto del desarrollo intelectual como del desarrollo de la personalidad. Cuanto menos grave sea el defecto primario, mayor será el papel que desempeñará el factor social y las condiciones de vida, tanto en su compensación, como en la conformación del cuadro de las desviaciones secundarias y terciarias del desarrollo.

En esta relación entre los defectos primarios, secundarios y terciarios se percibe con facilidad que las dificultades primarias son menos cambiantes, sin embargo, las secundarias y terciarias varían bajo la influencia pedagógica. Por estas

razones, la tarea pedagógica central no es eliminar la causa del defecto o el propio defecto, sino prestar atención a sus posibles consecuencias.

Para el **diagnóstico** de los escolares con retardo en el desarrollo psíquico es importante la consideración de los elementos diferenciadores con otras discapacidades. Las principales dudas surgen en comparación con el retraso mental de grado leve, por la semejanza externa de los indicadores de ambos grupos y los resultados del pronóstico de desarrollo. El diagnóstico del retardo en el desarrollo psíquico debe realizarse preferentemente en el plano psicológico y pedagógico, pues la sintomatología neurológica residual no puede servir de base para el diagnóstico diferencial, porque los síntomas semejantes, como por ejemplo, la cerebroastenia, puede observarse en algunos niños que sufren determinada enfermedad que afecta su sistema nervioso central.

Este diagnóstico es más exitoso si se apoya en la observación de los niños en diferentes actividades y en los resultados de las pruebas psicológicas y pedagógicas. En el área psicopedagógica se debe considerar como objetivo más importante no solo la constatación de retardo en el desarrollo, sino también dejar al descubierto la peculiaridad de este retardo el cual es totalmente diferente en cada uno de los niños que pertenecen a este grupo.

Una de las características particulares del retardo en el desarrollo psíquico es la irregularidad (heterogeneidad y falta del sincronismo) de la formación de los procesos psíquicos. Los estudios realizados por Pevzner M., Vlasova T., ; Lebedinskaya K, Domishkievich S., Lubovsky V. Torres M., Herrera L., Gayle A., Naranjo M. y González O., coinciden en que hay indicadores diferenciales entre los niños con retardo en el desarrollo psíquico y con retraso mental . Ellos se presentan a continuación.

- En los niños con retardo en el desarrollo psíquico, a diferencia de los que presentan retraso mental no se aprecian severas insuficiencias en el desarrollo de las operaciones del pensamiento, ni en la capacidad de realizar juicios lógicos, pero la inmadurez de la motricidad, de los procesos perceptivos, del lenguaje y de la esfera emotivo volitiva, junto al estado asténico general, disminuyen sustancialmente la productividad de su actividad intelectual. Se limitan las posibilidades de la formación efectiva de las nuevas habilidades y hábitos docentes cognoscitivos.

- Los niños con retardo en el desarrollo psíquico aceptan, utilizan la ayuda y la trasladan a situaciones semejantes en las actividades que no pueden realizar por si solos, lo que indica mayores potencialidades para su desarrollo en comparación con los niños con retraso mental. Durante el trabajo individual son capaces resolver con la ayuda tareas intelectuales casi al mismo nivel que sus coetáneos (realizar agrupaciones, determinar las relaciones de causa-consecuencia en relatos, comprender sentido figurado de los refranes, comprender el argumento de la lámina y de relato otros).
- Las insuficiencias de distintas funciones corticales en los niños con retardo en el desarrollo psíquico se compensan con mayor conservación de las otras y mayor conservación en las posibilidades de las interacciones entre las funciones, por eso, al confrontar dificultades en la solución de problemas visuales en imágenes, es fructífera una verbalización amplia y acciones prácticas. En el caso de los alumnos con retraso mental es necesaria la compensación de todos los elementos estructurales del acto intelectual.
- La inmadurez de la esfera emotivo-volitiva en los niños con retardo en el desarrollo psíquico no posee un carácter de pérdida, por eso en los niveles de actividad, típicas para un período etéreo menor, en ellos se aprecia la conservación primaria de las estructuras reguladoras y la posibilidad de su maduración.
- Los niños con retardo en el desarrollo psíquico se sienten bien en la actividad de juego, recurren a ella en aquellos casos, cuando sienten necesidad de dejar la actividad de estudio, difícil para ellos. Esto no ocurre en los niños con retraso mental.
- La diferencia existente entre el retraso mental y el retardo en el desarrollo psíquico se pone de manifiesto también en las desviaciones terciarias que surgen en la edad escolar. En el retraso mental estas poseen el carácter de insuficiencia total en el desarrollo de la personalidad, mientras que en el retardo en el desarrollo psíquico el carácter disarmónico de la personalidad se manifiesta en forma de inmadurez solamente en algunos de sus componentes, pero no en la insuficiencia de toda la estructura de la personalidad.
- En el retraso mental el insuficiente desarrollo de la personalidad está relacionado con las dificultades del pensamiento generalizador que no juega su

papel rector. En el retardo en el desarrollo psíquico este último también se retrasa, sin embargo, no pierde su función rectora con respecto a las demás funciones.

El retardo en el desarrollo psíquico también se debe diferenciar de los trastornos afectivos conductuales, debido a las manifestaciones de distractibilidad de la atención y el bajo rendimiento que en muchas ocasiones tienen estos alumnos en el aprendizaje escolar, producto de desmotivaciones, poca tolerancia a la frustración, inhibiciones para participar. Un aspecto fundamental para diferenciarlos son sus potencialidades para la realización de tareas intelectuales, no directamente relacionadas con desempeños escolares, por las alternancias en los resultados cuando se mejora su motivación. Estos aspectos informan de la conservación primaria de sus posibilidades cognitivas.

Es necesaria la intervención oportuna para evitarlas dificultades en el aprendizaje. Los fracasos escolares son uno de los primeros factores visibles para detectar este tipo de trastorno. Los maestros deben observar la conducta de sus educandos y realizar investigaciones en pos de mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. Una vía que indiscutiblemente es considerada para ello es el estudio de caso como instrumento o recurso para indagar en la vida psicosocial del sujeto, arribar a un diagnóstico explicativo y proponer la estrategia de intervención educativa.

Son innumerables los autores que abordan temáticas sobre el estudio de caso, los cuales son antecedentes de esta investigación. Guba y Lincoln (1981) plantean: "Se trata de un análisis completo o intensivo de una faceta, tema o suceso a lo largo de un tiempo. Es algo más que el relato de un ejemplo o una anécdota interesante, es el estudio de un ejemplo en acción...".

En otro escenario (Walter, 1983) destaca: "es el estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, permite al que lo realiza captar y reflejar los elementos de una situación que le dan significado".

Algunos autores sostienen: "el estudio de casos más que un método de investigación, es una forma de diseño de la investigación (Sabino, 1978) o una estrategia de investigación (Rodríguez Gómez y otros, 2002); mientras Orison

(2003), reconoce, además, la importancia del estudio de casos como método de enseñanza, válido sobre todo en el área de las ciencias sociales”.⁵

En esta investigación se asume la definición dada por Marta Torres (2004): “el estudio de casos es un proceso de análisis, reflexión y debate que realiza el equipo interdisciplinario que participa en la evaluación y estudio de un sujeto, con el objetivo de explicar las características de su desarrollo evolutivo y los posibles factores causales que han determinado las mismas”.⁶ Esta definición es abarcadora, destaca la influencia de agentes educativos, factores internos y externos que intervienen en el proceso de estudio y análisis para la profundización en el individuo objeto de estudio. Hace alusión al carácter sistémico de la investigación lo que contribuye a la solución de problemáticas.

La guía metodológica asumida es la propuesta por ÁlvarezC. mediante la cual se logró un adecuado conocimiento del desarrollo evolutivo del educando en los diferentes contextos, causas y estrategias para corregir y/o compensar las necesidades existentes, teniendo en cuenta los fundamentos pedagógicos, biológicos, sociales y psicológicos. Además, se utilizaron métodos empíricos como la observación, entrevista, entre otros instrumentos de evaluación psicológica, que permitieron realizar un diagnóstico exhaustivo del desarrollo del educando y las causas que originaron las alteraciones para arribar a un diagnóstico más actualizado.

El estudio de caso, que a continuación se propone, explica la vida psicosocial del menor seleccionado, prioriza sus potencialidades y necesidades.

⁵ Colectivo de autores. El estudio de caso como método científico de investigación en la escuela.

⁶ Torres, M. Metodología para el estudio de caso, 2004.

I Datos generales

Nombre y Apellido: C.C.P

Fecha de nacimiento: 05 de noviembre del 2011

Sexo: Masculino

Edad: 7 años

Grado: 3er grado

Curso: 2019-2020

Dirección Particular: Calle 69 # 2218E/Calle 22A y Calle 24, Reparto la Caridad, Municipio Cotorro.

II Motivo de selección para el estudio de caso

Escolar presentó necesidades en el área del lenguaje y el aprendizaje

III Características del entorno familiar

En su hogar conviven su papá, su mama, sus dos hermanos de 17 y 22 años y su abuelo paterno.

El ambiente familiar es favorable, dado que la mayor parte del tiempo goza del apoyo y el cariño de sus padres y sus necesidades básicas como alimentación, ropa, aseo etc. están cubiertas por sus mayores. En ocasiones el ambiente familiar se ve afectado en su dinámica porque su padre y su abuelo, padecen de alcoholismo, por tanto cuando están bajo los efectos de esta sustancia tienen comportamientos violentos delante del niño con otras personas de su familia, lo que está generando en ella determinados miedos y conductas retraídas.

En su hogar, trabaja su padre en la empresa recuperadora de materia prima como obrero, trayendo a casa un sueldo estable; y su hermano mayor trabaja en el hospital Militar como obrero y ayudante de cocina; los demás miembros de la familia aportan de manera menos estable y contribuyen a otras tareas del hogar.

El niño se ha criado en un barrio en el que los vecinos son muy unidos, y su familia mantiene buenas relaciones, por tanto se desarrolla en un ambiente en el que convive con otros niños cercanos y juega con ellos. Es un niño que en las relaciones con otros niños de su edad, es dinámico, activo y ocupa siempre el rol del líder en los juegos. Por su personalidad, es así también en sus relaciones con los compañeros de su aula y de su escuela, siendo un niño extrovertido y alegre.

IV Características del entorno escolar

Escolar que cursa el 3er grado con dificultades en el área de la comunicación y la conducta lo que influye en su aprendizaje que es lento. Aprende mediante el canal visual y kinestésico, su atención está afectada en cuanto a concentración, por tanto es distráctil, poca duración del tiempo concentrado en la actividad, su atención voluntaria requiere de estímulos tecnológicos y motivacionales; el horario más factible para la asimilación de los contenidos es en la mañana de 8:00 am a 10:45; luego se duerme y evade la actividad; cuando se concentra lo hace muy limitado con poca constancia y estabilidad. Se muestra motivado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En ocasiones es inseguro dice: "no puedo hacerlo" y ante las dificultades se muestra voluntarioso, agresivo y ansioso al punto de abandonar la actividad. Necesita de trabajo individual y diferenciado. Responde de manera positiva ante ejercicios lúdicos. Valora su propio esfuerzo, se estimula imitando un personaje animado y se siente satisfecho ante su trabajo. Prefiere los juegos activos y participa con entusiasmo en la asignatura Educación Física, posee habilidades para el deporte, pero no logra rol protagónico en este.

En Lengua Española con corrección (semioracional) y cierta fluidez, logra sencillas explicaciones de lo que lee, requiere de preguntas de apoyo para responder a las actividades. Su vocabulario es pobre y en ocasiones no logra que su explicación sea coherente. Redacta oraciones con pobreza en su vocabulario. Presenta dificultades en los trazos. Presenta dificultades en los sonidos como c r rr t s. Presenta dificultades en el trazado y enlace de las letras, al escribir con la letra inicial mayúscula.

En Matemáticas forma, lee, escribe, compara y ordena números naturales hasta el 100. Calcula ejercicios básicos de adición sin sobre paso y con sobre paso y presenta dificultades en los de sustracción. Calcula ejercicios básicos de multiplicación y división con algunas dificultades, debido a que requiere de niveles de ayuda para la realización de estos. Presenta dificultades para resolver problemas simples y compuestos. Reconoce cuadrados, triángulos,

rectángulos y círculos en figuras incluidas unas dentro de otras, fundamenta sus características con niveles de ayuda.

En Educación Laboral realiza modelados con plastilina, trabajos con papel, utiliza correctamente la tijera, el pincel para untar el pegamento y le gusta recortar, rasgar, dibujar y confeccionar objetos con diferentes materiales. Tiene habilidades manuales.

Desde el punto de vista logopédico su lenguaje dialogado está afectado en cuanto a recepción del mensaje. Se siente cómodo e interesado con los ejercicios que realiza en el gabinete. Se expresa de forma oracional sencilla con frases cortas, poca espontaneidad y fluidez, escaso vocabulario, disminuido en calidad y cantidad, falta de logicidad en las ideas y descontextualización del lenguaje, omite algunos elementos gramaticales en su expresión oral, afectados los componentes del lenguaje (semántico, pragmático y morfosintáctico).

V Dinámica del menor seleccionado

Padece de asma, y su desarrollo físico motor es normal, desde su nacimiento, hasta el momento, sin anomalías ni retrasos en dicho desarrollo. Sus principales aficiones son jugar a los carritos, ver muñequitos de súper héroes y jugar con sus amiguitos. Tiene fortalezas como el cuidado de sus padres desde que se diagnosticó su asma y la atención a la estimulación su desarrollo psico motor por los adultos con los que convive.

Parto distócico (cesárea) a las 42 semanas, peso 7.5 kg, talla 51. No requirió de reanimación al nacer, se le realizó la prueba de fenilcetonuria. En el proceso de lactancia presentó poco reflejo de succión. Recibía el alimento, extraído a la madre, a través de un pomo auxiliar hasta los tres meses. Fue dado de alta del hospital a los cinco días. Tuvo malos hábitos en el uso del dedo y el tete. En el desarrollo psicomotor el sostén cefálico ocurrió a los seis meses, gateó a los siete meses, se sentó a los seis o siete meses, primeros pasos a los diez meses, mantuvo el equilibrio al año.

Nació con reflejo gastroesofágico y vomitaba con frecuencia, tuvo tratamiento de Metrocloplamida y a partir de los siete meses con la Domperidona hasta los

14 meses. Desde su nacimiento padece de alergia con varios tratamientos y se atiende con el inmunólogo. En las pruebas realizadas le diagnosticaron que era susceptible a los virus.

A los dos años solicita el círculo infantil pero no había capacidad por la falta de personal. Es entonces cuando la abuela paterna se encarga del cuidado del niño mientras la madre trabajaba. Vivió un año aproximadamente allí y en este periodo no se relacionaba con otras personas, la abuela le ponía los muñequitos para poder hacer las funciones en el hogar ya que el escolar era muy travieso y solo se quedaba tranquilo con los muñequitos.

Luego de esperar la llegada del círculo asiste al Círculo Infantil: Batalla de Ayacucho a los 3 años. Estuvo un mes para adaptarse y su estado emocional era irregular, lloraba con frecuencia y se relacionaba poco con el resto del grupo y las señas; se interesaba poco por las actividades. Su asistencia y puntualidad fue buena y se manifestó la preocupación de la madre.

Empleó la mímica para comunicarse. Respondía a su nombre. La madre no recuerda la aparición del gorjeo y balbuceo. Las primeras palabras fueron a los tres años, no empleó el lenguaje oracional. Cuando se le mandaba a buscar algo lo entendía y lo buscaba. Se expresaba en jerga ininteligible.

Desde pequeño fue muy hiperactivo y solo se tranquilizaba con los animados. Su sueño no era tranquilo, llanto constante ante cualquier estímulo del medio, por ejemplo: si el juguete se le caía al piso y no se lo alcanzaban rápido se mostraba irritado, y su madre decide asistir a un psicólogo por la conducta que manifestaba. Es el psicólogo quien le orienta a un psiquiatra infantil y luego de varias pruebas le diagnosticaron Retardo en el desarrollo psíquico. Se atiende en el pediátrico de Centro Habana en consultas de psiquiatría cada tres meses.

A los dos años y medio asistió a consultas de logopedia de forma irregular donde recibió orientaciones para estimular el lenguaje del escolar. Imitaba patrones lingüísticos y conductuales de los animados infantiles.

En el curso 2017-2018 se incorpora a la escuela primaria América Lavadí Arce en el grado preescolar, la madre solicita al Centro de Diagnóstico y Orientación la evaluación del escolar y le negaron ir a la escuela del lenguaje porque en el

centro donde lo ubicaron supuestamente iba a erradicar las dificultades en el lenguaje.

Se orientó a la familia para que el niño observara menos cantidad de animados porque su lenguaje era imitando a personajes infantiles, además su modo de actuación ante situaciones concretas era excesivamente fantasioso. Se trazaron estrategias para estimular el lenguaje desde todos los contextos. Se manifestaba agresivo con la maestra y permanecía aislado del grupo por morder, golpear a niños, incluso, a la propia maestra. Los resultados obtenidos en el grado preescolar demuestran que no venció los objetivos.

Actualmente se encuentra en el grado primero con serias dificultades en la comunicación, la conducta y el aprendizaje. Recibe tratamiento con psicofármacos: Carbamazepina $\frac{3}{4}$ tableta en el desayuno y $\frac{1}{2}$ tableta a las 4:00 pm y Tioridazina $\frac{1}{2}$ tableta en el desayuno. En la última consulta en el mes de febrero le suspendieron la dosis del Metilfenidato por el comportamiento (se dormía en el aula). Para la alergia toma Difenhidramina $\frac{1}{2}$ tableta dos veces al día.

VI. Fundamentación de la estrategia de evaluación

Técnicas aplicadas:

- Visita al hogar con el **objetivo** de obtener información que corrobore los datos pre, peri y postnatal del menor.
- Entrevista a la maestra con el **objetivo** de precisar las potencialidades y necesidades en la esfera afectivo-cognitiva del menor.
- Entrevista a la psicopedagoga con el **objetivo** de obtener información sobre el diagnóstico y estrategia de intervención del menor.
- Guía de observación con el **objetivo** de observar la conducta en las actividades diarias del menor.
- Técnicas de exploración logopédica con el **objetivo** de comprobar el estado del lenguaje de los escolares. Ver en los anexos la Hoja de exploración logopédica
- Reconocimiento de los fonemas con el **objetivo** de corroborar si el menor conoce estos.

- Dibujo libre con el **objetivo** de observar las habilidades motrices y sensibilidad artística del menor.
- Dibujo de la familia con el **objetivo** de observar las habilidades motrices y afectividad del menor hacia su familia (miembros).
- Técnica del completamiento de frases con el **objetivo** de explorar las motivaciones del niño y también para precisar el nivel de vocabulario de escolar.

VII Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica

Visita al hogar (entrevista a la madre y al padre)

En su hogar conviven su papá, su mamá, sus dos hermanos de 17 y 22 años y su abuelo paterno.

En su hogar, trabaja su padre en la empresa recuperadora de materia prima como obrero, trayendo a casa un sueldo estable; y su hermano mayor trabaja en el hospital Militar como obrero y ayudante de cocina; los demás miembros de la familia aportan de manera menos estable y contribuyen a otras tareas del hogar.

El ambiente familiar es favorable, dado que la mayor parte del tiempo goza del apoyo y el cariño de sus padres y sus necesidades básicas como alimentación, ropa, aseo etc. están cubiertas por sus mayores. En ocasiones el ambiente familiar se ve afectado en su dinámica porque su padre y su abuelo, padecen de alcoholismo, por tanto cuando están bajo los efectos de esta sustancia tienen comportamientos violentos delante del niño con otras personas de su familia, lo que está generando en ella determinados miedos y conductas retraídas.

Maestra

La maestra refiere que el educando se encuentra en un grado de desarrollo limitado, relacionado con nociones elementales. Es un niño intranquilo, se le afecta la atención de manera dispersa, hiperactivo". Comprende a través de preguntas de apoyo y niveles de ayuda.

Psicopedagoga

No está de acuerdo con el diagnóstico del menor. Insiste en que debe ser reevaluado, atendido por especialistas como el logopeda, el psiquiatra y el psicólogo; y además debe estar en una escuela especial.

Cuarto excluido.

En esta técnica se mostró intranquilo. Realizando la actividad preguntaba: ¿lo estoy haciendo bien? Muestra incoherencias en sus respuestas. Se evidencian dificultades en la generalización.

Hoja de exploración del lenguaje.

Escuela Primaria: América Lavadí Arce

Nombre y Apellidos: C.C.P

Expediente del CDO: ---

Fecha de nacimiento: 05 de noviembre del 2011

Edad: 7 años

Sexo: masculino

Grado: 3ero

Cursos de repitencia: ---

Motivo de consulta (quejas de padres y maestros)

Remitido por el maestro.

-Se expresa incorrectamente.

-Dificultades para diferenciar un sonido de otro.

-Dificultades en la adquisición del código de la lectoescritura.

Datos concretos sobre la evolución del lenguaje:

La madre no recuerda cuando ocurrieron las etapas de gorjeo y balbuceo, utilizó la mímica para comunicarse, a los tres años decía algunas sílabas y palabras aisladas. Comenzó a caminar al año.

Otros datos de interés

Desde pequeño observa muchos muñequitos, su lenguaje y su conducta son imitando personajes animados. Tiene dificultades para concentrarse en la escuela.

Examen específico del habla. Estado del aparato articulatorio:

Presenta poca movilidad del ápice lingual y del velo del paladar, la úvula y los labios son normales, dientes pequeños.

Características de la audición:

Normal con dificultad en los procesos fonemáticos. Visión y motricidad son normales y respiración clavicular.

Conversación espontánea:

Es poco comunicativo y espontáneo, su lenguaje conversacional carece de logicidad en las ideas, poca fluidez y omite algunos elementos gramaticales.

Estado del vocabulario y la construcción gramatical:

Vocabulario medio disminuido en cantidad y calidad. El vocabulario activo es pobre

Comprensión:

Comprende órdenes sencillas y cuando se complejizan necesita hasta un cuarto nivel de ayuda, tiene falta de logicidad en sus ideas.

Análisis de la pronunciación y de los procesos fonemáticos:

Dificultades en la diferenciación de los sonidos disyuntivos y correlativos. Distorsiona /r/ en posición media y /rr/ en posición inicial, media y final, distorsiona las sílabas directas dobles en inicio y media; omite inconstantemente el fonema /f/; cambia /t/ por /d/ y /s/ por /ch/.

Observaciones: Se fatiga con facilidad y presenta dificultades para concentrar su atención

Ritmo y fluidez del lenguaje:

Habla con cierta lentitud, acorta las palabras.

Características de la voz:

Intensidad: normal

Tono: agudo

Timbre: sonoro

Entonación: monótona

Examen de la lectura y la escritura.

Escritura:(En desarrollo) Presenta dificultades en la motricidad fina, trazos fuertes y responde lentamente en la adquisición del código de la lectoescritura.

Conducta observada durante la prueba: Se muestra intranquilo, con deseos de terminar e irse a su aula.

Diagnóstico logopédico:

Teniendo en cuenta los datos antes mencionados, llegamos a la conclusión de que el menor presenta trastorno de la comunicación oral nivel lenguaje: retraso simple del lenguaje.

Dibujo libre

En este dibujo hizo la representación de una lluvia ya que dice que le gusta mucho dormir cuando llueve, tiene bastante precisión en los trazos y en el que también hizo unas nubes de color azul, dibujó una casa con el techo de color morado y las paredes de verde. También dibujó un árbol y unas flores Utiliza trazos fuertes y débiles. Se evidencia ansiedad

Dibujo de la familia

En este dibujo pintó a su papá, a su mamá y a uno de sus hermanos omitió a su hermano mayor porque no tiene mucha comunicación con este; El color que empleó fue un anaranjado, que indica una vez más ansiedad, a un lado dibuja su casa de color morado. Es importante añadir que a todos los miembros están sonrientes lo que indica que vive en un ambiente favorable.

Potencialidades:

Tiene habilidades manuales.

Presta interés por las tecnologías.

Siente motivación por las actividades lúdicas y dinámicas.

Se interesa por trabajar en el gabinete logopédico.

Necesidades:

Trabajar la articulación de fonemas correlativos y disyuntivos.

Desarrollar la atención a través de juegos didácticos.

Mantener la atención psiquiátrica.

Establecer relaciones con otros niños de su edad.

Ampliar vocabulario activo y pasivo a través de láminas, paseos, videos, entre otros.

VIII. Diagnóstico explicativo

C.C.P. es un niño que cursa el primer grado en la escuela primaria América Labadí Arce presenta un trastorno del nivel comunicativo lenguaje: retraso simple del lenguaje asociado a Retardo en el desarrollo psíquico. Durante la exploración se mostró cooperador, motivado, inquieto y su atención muy distráctil. Presenta dificultades en los tres componentes de la lengua fónico-léxico-gramatical y en los procesos cognoscitivos. Necesita de constante estimulación para realizar las actividades. Se siente motivado por la tecnología y las actividades manuales. Se comunica oralmente a través de frases sencillas y utiliza pocos elementos gramaticales, su respiración es clavicular. Refleja

dificultades en la motricidad fina y articularia. Su vocabulario activo y pasivo es pobre, refleja dificultades en la generalización.

IX Estrategia de intervención

Objetivo: Corregir y/o compensar el trastorno de la comunicación oral del nivel del lenguaje, la pronunciación, la discriminación auditiva para el enriquecimiento del lenguaje y el desarrollo de la personalidad, haciendo énfasis en los procesos relacionados con el aprendizaje y la conducta

Tareas:

1. Realizar de manera sistemática orientaciones a la familia, a la psicopedagoga y a los maestros sobre cómo desarrollar el área de la comunicación y el lenguaje mediante las siguientes actividades:

- Crear situaciones cotidianas donde tenga que expresar lo que desee, no responder en lugar del niño.
- No exigirle que pronuncie de forma perfecta, no rectificarle constantemente, utilizar el lenguaje del adulto como modelo.
- No utilizar diminutivos.
- Estimular la pronunciación de sonidos aislados, asociándolos con láminas u objeto que lo relacionen.
- Realizar actividades de atención voluntaria.
- Preguntar sistemáticamente su nombre, el de sus padres, amiguitos.
- Conversar directamente con él sobre la escuela, los estudios, el proceso de aseo y alimentación.
- Realizar ejercicios para el desarrollo de la praxis articularia.
 - Cantar canciones infantiles.
 - Narrar cuentos con apoyo de láminas.
 - Usar siempre oraciones completas.
 - No gritarle.

2. Desarrollar el lenguaje:

Desarrollo del vocabulario, la pronunciación y la estructura gramatical mediante:

- Ejercicios fonoarticulatorios.
 - Jadeo del perro.

- Sacar y meter la lengua.
- Soplar.
- Tirar besos.
- Vibración bilabial.
- Imitar o producir sonidos (con palmadas, trompetillas, chasquido lingual).
Ejercitar la rítmica logopédica.
- Producir sonidos vocálicos y asociarlos a grafemas
- Creación de situaciones comunicativas que demandan la comprensión y producción de palabras para denominar objetos y fenómenos, describir y narrar frases sencillas.
- Denominar personas u objetos (su utilidad).
- Trabajar los oficios e indagar en sus preferencias.
- Organizar juegos con adivinanzas, poesías, canciones, dinámicas de competencias de resolución de ejercicios matemáticos.

3. Continuar con la atención especializada del psiquiatra por el área de salud.

- Estimular el desarrollo de hábitos de cortesía.
- Incorporar en actividades ejemplo: matutinos, repartir las libretas, participar en la pizarra, dándole papeles protagónicos e indicándole la secuencia de acciones lógicas a desarrollar en los mismos.
- Establecer reglas y límites claros en el desarrollo de todas las actividades.
- Asignarle encomiendas dentro del grupo.
- Incorporarlo a las actividades recreativas que se desarrollan en la comunidad que estén acorde a su edad cronológica, propiciando así la relación con "otros".
- Brindarle muestras de afecto, cariño y seguridad en todos los horarios del día.
- Estimular sus logros.
- Disminuir el tiempo establecido para la visualización de programas televisivos (muñequitos).
- Formación de conjuntos por una característica.
- Comparar objetos, como animales-frutas-medios de transporte.
- Dibujos según modelos sencillos.
- Ensartes siguiendo modelos y guías.
- Realizar juegos de dominó infantil..

- Estimular la motricidad fina.
 - Ordenamiento de secuencias de láminas.
4. Lograr involucrar a la familia en la potenciación del desarrollo de la personalidad del niño.
- Realizar Escuelas de Educación Familiar para preparar a la familia en las habilidades a desarrollar en el hogar que estimulen las diferentes áreas del desarrollo.
 - Charlas educativas sobre los métodos educativos que se deben utilizar en la educación de su hijo.
 - Charlas educativas donde se valore la importancia de asistir a los especialistas del área de salud.
 - Visitas al hogar donde se compruebe el cumplimiento por la familia de todas las recomendaciones que se le han brindado.

Sistema de tratamientos logopédicos para un escolar con retraso del lenguaje asociado a un retardo en el desarrollo psíquico. Su fundamentación.

Tratamiento #1

Eje temático: "Las partes del cuerpo"

Objetivo: Ejercitar la respiración costo diafragmática

Método: Explicación

Procedimientos: Imitación, demostración.

Medios de enseñanza: láminas, canción, espejo, búcaro con flores aromáticas.

Material verbal: lengua, boca, dientes, nariz, ojos, barriga, piernas.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

Hoy vamos a visitar imaginariamente un parque. Cerramos nuestros ojos y respiramos por la nariz hasta que la barriga se hinche y lo expulsamos por la boca. Nos encontramos en un lugar donde hay silencio y muchos árboles con flores, que dan sombra a los banquitos del parque donde estamos sentados. Hay muchas flores en el lugar, respiremos su olor. (Llevar flores aromáticas). A

lo lejos hay un río ¡Caminemos hasta allí! Está limpio y el agua está fría. Se escuchan pájaros volando cerca de aquí (Proyectar sonidos de la naturaleza). Luego nos montamos en un bote para dar un recorrido por el río, movemos las manos para remar, nos bajamos del bote y caminamos hasta llegar a la cafetería para comer frutas.

¿Te gustó la actividad?

Desarrollo

Explicar cómo respiramos correctamente. Realizar tres veces cada sección de ejercicios.

Sección 1: En posición de sentado, frente al espejo, inspiramos y espiramos.

Sección 2: En posición de parado, con los brazos al lado del cuerpo, respirar, colocar la mano derecha en la barriga y observa cómo se hincha y luego expulsa el aire por la boca.

Sección 3: En posición de acostado, colocar la mano izquierda encima de la barriga para que observe como sube al tomar el aire por la nariz y baja cuando se expulsa por la boca.

Tener en cuenta la corrección si alza los hombros, expulsa el aire por la nariz u otras formas incorrectas de respiración.

Mostrar lámina del cuerpo humano. Posibles preguntas:

Cuando respiramos, ¿por dónde debemos tomar el aire? / por la nariz

Y al expulsarlo debe ser por la boca.

Señala en la lámina dónde está la nariz y dónde está la boca.

¿Hacia dónde va el aire que respiramos? / Hacia la barriga

Señala donde está tu barriga.

Conclusiones:

Realiza un dibujo donde muestres cómo imaginaste el lugar que visitamos.

Evaluación

¿Cómo trabajaste hoy?

- ✓ Si realizaste los ejercicios correctamente, respondiste las preguntas bien y te mostraste interesado, obtienes estrella roja.
- ✓ Si respondiste bien las preguntas, realizaste algunos ejercicios correctamente y tuviste poca participación, obtienes estrella azul.
- ✓ Si respondiste las preguntas incorrectamente al igual que los ejercicios y tuviste poca participación, obtienes estrella blanca.

Tarea:

Realizar en la casa ejercicios de respiración costodiafragmática. Pide ayuda a tus padres.

Traer palabras que tengan el sonido /b/.

¡Hasta la próxima clase!

Tratamiento #2

Eje temático: Las partes de la cara.

Objetivo: Ejercitar la movilidad lingual y articulatoria y demostrar el perfil articulatorio del fonema /b/.

Método: Demostrativo.

Procedimiento: Imitación y control visual.

Medios de enseñanza: video, tarjetas, espejo, juguete de hacer burbujas, voz del maestro.

Material verbal: boca, labios, beso, burbujas, babero, biberón.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

Pedir que muestren sus tareas realizadas para que nombren las palabras que buscaron. En caso de no haberla hecho, mostrar tarjetas con este fin.

Hoy estaremos acompañados de unos amigos que nos vienen a visitar, nos van a enseñar algo nuevo y divertido.

¿Quieres saber qué es?

Proyectar video de la lengua saltarina.

El niño va a observar cómo "otros" niños realizan ejercicios de movilidad lingual.

¿Te gustó el video?

Imita los ejercicios frente al espejo.

¿Qué hacían los niños? Mover la lengua, los labios,

¿Dónde está nuestra lengua? En la boca

¿Qué podemos hacer con nuestra boca?

Comemos: ejecutar acción (imaginemos que estamos comiendo un dulce muy delicioso y se nos embarraron los labios de merengue) Pasar la puntica de la lengua por las comisuras labiales.

Hablamos: decir palabras aisladas (utilizar el material verbal)

Besamos: dar un besito a la maestra o algún miembro de la familia que nos acompañe (señalar los labios)

Jugamos también... te enseño un juego.

Jugar a hacer burbujas. Ejercicio de soplo.

¡Ahora vamos a reflexionar!

¿Con qué pudimos ver el video? Con nuestros ojos

Tuvimos que respirar por la nariz y expulsar el aire por la boca para poder hacer burbujas.

Conclusiones: Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado.

Se muestra una lámina con las partes de la cara para nombrar: boca, labios, nariz, ojos, orejas.

Cierra los ojos y nombra palabras con el sonido /b/.

Evaluación

¿Cómo trabajaste hoy?

Dar la distinción según los resultados del trabajo.

Tarea:

Realizar ejercicios de movilidad lingual frente al espejo.

Con ayuda de tus padres busca, recorta y pega en tu libreta láminas de animales que viven en la tierra.

¡Hasta la próxima clase!

Tratamiento #3

Eje temático: Los animales terrestres

Objetivo: Identificar el fonema /t/ y /b/ en sílabas y palabras; y ejercitar la percepción fonemática.

Método: Demostrativo.

Procedimientos: Observación, explicación.

Medios de enseñanza: Espejo, tarjetas, lámina, video, grabaciones de sonidos.

Material verbal: totí, pajaritos, tortuga, gato, tigre, ternero, pollito, burro.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

¿Te gustan los paseos?

Hoy vamos a visitar un lugar muy interesante

Proyectar video de animales en el zoológico.

Orientar el objetivo

¿Qué observaste? / Animales

¿Dónde se encuentran? / En el zoológico. ¿Alguna vez tú lo has visitado?

¿Puedes mencionar el nombre de alguno de ellos?

Hacer juego para ejercitar la memoria. Se muestran cuatro tarjetas que representan dos parejas de animales. El niño observa y luego se voltean las tarjetas para que escoja las dos iguales.

Conclusiones: Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado.

Tarea: Realiza los ejercicios trabajados en la clase frente al espejo.

¡Hasta la próxima clase!

Tratamiento # 4

Eje temático: Los animales marinos

Objetivo: Pronunciar el fonema /p/ mediante sílabas, palabras y oraciones.

Método: Demostración

Procedimientos: Observación, explicación.

Medios de enseñanza: Láminas, video, música, arena de mar, espejo individual y colectivo.

Material verbal: peces, playa, pulpo, pez

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas.

Motivación inicial. Adivinanza

Es su casa el mar

y todos allí conviven,

en un universo
de colores increíbles. (los peces)

Preguntas de comprensión

¿Quiénes viven en el mar?

Orientar el objetivo

Desarrollo:

Hacer análisis fónico de la palabra peces. ¿Cuántas vocales tiene? ¿Con qué sonido comienza?

Mostrar perfil articulatorio del fonema /p/. Ir al espejo y explicar la posición articulatoria del fonema.

Como dinámica podemos imitar con nuestros labios como hace la boca de los pececitos.

Y después continuar con otro ejercicio. Aproximar ambos labios ejerciendo la presión necesaria entre ellos, llenar de aire ambas mejillas y después de mantener un instante el aire en la boca, expulsarlo bruscamente, dando un sonido de la onomatopeya P más la vocal e bien fuerte y explosivo.

Combinar el sonido con las vocales pa, pe, pi, po, pu y hacer alargamiento vocálico paaaaaa, peeeee, piiiii, poooo, puuuuu

Mostrar el video musical “Bajo del mar” ¿Te gustan los peces? Menciona los colores de alguno de ellos.

Entregar silueta de un pez para que dibuje el contorno y rellene el área.

¿Qué otros animales marinos conoces? ¿Por qué les llamarán marinos? ¿Has visitado la playa? Enseñarle arena de playa y que el niño la identifique por su nombre.

Realiza una oración con la palabra peces.

Te invito a pasear en un barco velero por la playa. Se le pide que sople la vela para navegar. Ejercicio de soplo, repetir en series de a tres.

Está formado por figuras geométricas. Identifícalas.

Conclusiones:

Se realizan preguntas: ¿Dónde viven los animales trabajados en clase?
¿Pueden vivir fuera del mar? ¿Por qué? ¿Crees que es importante entonces cuidar el mar?

Evaluación

¿Te gustó la clase? ¿Cómo trabajaste hoy?

El logopeda evaluará según la participación, desempeño en la actividad y calidad en las respuestas.

Tarea

Escribe tres oraciones con las siguientes palabras: avión, carro, motor. Practica la lectura.

¡Hasta la próxima clase!

Tratamiento #5

Eje temático: Los medios de transporte

Objetivo: Articular el fonema /r/ en sílabas y palabras con énfasis en el desarrollo psicomotor.

Método: Explicativo

Procedimientos: Observación.

Medios de enseñanza: Espejo, tarjetas, lámina, computadora, software educativo, perfil articulatorio.

Material verbal: carro, motor, ruido, camionero, conductor, chofer.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

Comenzar con el trabalenguas: erre con erre cigarra, erre con erre carril, rápido corren los carros, por la línea del ferrocarril.

Desarrollo

Mostrar láminas de diferentes medios de transporte. Mencionar el nombre.

Imitar el sonido del motor. Realizar dinámica. Encendemos el motor del carro. Vibración bilabial relajando la lengua, mejillas y labios y hacer vibrar la lengua con la vibración de los labios de forma mantenida y ruidosa imitando el sonido de un motor en series de a tres. Calentamos el motor. Se colocan las manos como si fuéramos a conducir. Y nos ponemos de pie y caminamos alrededor del aula haciendo la vibración más vocal acentuada en series de a tres. Se repite varias veces (lento-rápido).

Ayuda al camionero, al guagüero, al piloto y al chofer del carro a llevar a los pasajeros a un recorrido por la ciudad; debes realizar el trazo correspondiente a cada medio de transporte. No olvides sentarte correctamente y utilizar bien el lápiz.

Realiza la siguiente actividad: une los puntos del 1 al 10 y luego colorea.

Construye oralmente una oración a partir de la siguiente lámina.

Conclusiones: Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado.

Evaluación

¿Cómo trabajaste hoy?

El logopeda evaluará según la participación, desempeño en la actividad y calidad en las respuestas.

Estimular con figuritas de diferentes medios de transporte según la conducta observada.

Tarea

Realiza los ejercicios logopédicos en la casa con ayuda de tus padres. Se envía una nota que explique lo que el niño debe hacer.

Cuéntale a un compañerito del aula lo que hiciste en el gabinete logopédico.

¡Hasta la próxima clase!

Tratamiento #6

Eje temático: Las partes de la casa

Objetivo: Nombrar el fonema /c/ y pronunciar el fonema /r/ mediante sílabas inversas de palabras y oraciones con énfasis en el desarrollo lingüístico y cognitivo.

Método: Demostrativo

Procedimientos: Observación, narración.

Medios de enseñanza: Espejo, tarjetas de exclusión, voz del maestro,

Material verbal: casa, jardín, cocina, escoba, cuarto, comedor, portal,

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

Formar con figuras geométricas una casa. Te invito a conocer esta casa y ver que hay allí.

Desarrollo

Se le muestra una lámina de las partes de la casa.

Realizar el análisis fónico de la palabra casa.

Mostrar perfil articulatorio del fonema /c/

Se muestra una lámina de una familia realizando actividades en las diferentes partes de la casa. ¿Con cuál te identificas? ¿Ayudas a tu mamá, a tu papá y a

tu hermana en algunas actividades de la casa? Cuéntanos. Narrar un pequeño cuento con ayuda del logopeda donde el escolar sea el protagonista.

Mientras el niño narra su historia podemos decirle que en el cuarto hay un bebé llorando por su tete. Se introduce el ejercicio. Busquemos el tete del bebé diciendo tttttdddddttttttdddddttttttdddddttttddddd

El ejercicio puede ir acompañado de movimientos con las manos y variar el ritmo del sonido rápido- lento.

¿Cuál es la parte de la casa que más te gusta? ¿Por qué?

A mí me gusta el garaje porque allí guardo el carro. ¿Recuerdas como hace el sonido del motor del carro? Demuestra el ejercicio.
brumbrumbrumbrumbrumbrum

Ejercicios de chasquido de la lengua lento-rápido y viceversa.

Redacta oraciones con la palabra jardín y comedor.

Se le presenta al niño una lámina con diferentes objetos y se le pedirá que los identifique (jabón, cepillo de dientes, toalla, pasta de dientes, perfume) y mencione en que partes de la casa lo encontramos(baño) y diga su utilidad.

Vamos a dibujar las partes de la casa. Empezamos por la sala luego el comedor, los cuartos, la cocina y el patio.

Conclusiones:

Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado y conversar sobre la importancia que tiene participar en las labores del hogar.

Evaluación

¿Cómo hiciste los ejercicios? ¿Te gustaron las actividades?

- ✓ Si realizaste todas las actividades correctamente recibe estrella dorada.
- ✓ Si realizaste algunas actividades bien, pero la conducta no fue la mejor recibes estrella plateada.

- ✓ Si no realizaste las actividades correctamente y tu conducta no fue buena espera al próximo encuentro a ver si lo logras.

Tarea

Traer palabras con la letra /f/ al inicio.

¡Hasta la próxima clase!

Tratamiento #7

Eje temático: La escuela.

Objetivo: Identificar palabras con el sonido /f/ y describir la posición articulatoria del fonema /r/.

Método: Explicativo.

Procedimientos: Identificar, observar, nombrar.

Medios de enseñanza: Espejo, tarjetas de exclusión, útiles de la escuela, foto, cajita de sorteo.

Material verbal: maestra, pioneros, escuela, feo, fácil, final, fiesta, fondo, feliz, fecha, foto, ficha.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

¡Hoy vamos a jugar! ¿Te gusta jugar? ¿A qué te gusta jugar?

Tratar que digan la mayor cantidad de juegos posibles. ¿Por qué te gusta ese juego?

¡Hoy jugaremos a la escuelita!

Primero vamos a sortear los personajes. El niño escogerá un papelito de la cajita para saber el personaje a interpretar.

Si escoge el papelito de maestro les enseñará a los alumnos los ejercicios, realizará preguntas que le orientará el logopeda, se desarrollará la actividad docente a la que están habituados.

Desarrollo

Piensa y responde palabras que empiecen con /f/

12 de mayo del 2012 ¿Qué es? R/ Una fecha.

Lo contrario de difícil es.... R/ Fácil

Lo contrario de principio es.... R/ Fin

Lo contrario de bonito es... R/ Feo

Presentar una foto para que la describa. ¿Qué es? R/ Una foto

¿Qué observas en la foto? R/ Una fiesta

¿Cómo están todos en la fiesta? R/ Felices

¿Qué otra palabra podemos mencionar para decir que están felices? R/ Contentos, alegres, risueños.

Presentar tarjetas de exclusión.

Observa y nombra los útiles de la escuela. ¿Señala cuál no pertenece a ese grupo? R/ El carro ¿Por qué no pertenece?

¿Cómo hace el motor del carro? Rrrrrrrrrr

Ir frente al espejo

Con la punta de la lengua golpear ligeramente la parte de atrás de los dientes superiores, luego tratar de emitir d, d, d... superficial y rápidamente en esta posición.

Hacer vibraciones bilabiales largas y ruidosas.

Indicar la posición articulatoria y pedir al niño que lo repita, haciendo el ruido del motor del carro.

Conclusiones: Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado.

¿Qué palabras pronunciamos hoy que tenían el sonido /f/?

¿A qué jugamos? ¿Te gustó el juego?

¿Qué sonido realizamos frente al espejo?

Evaluación

¿Cómo trabajaste hoy?

El logopeda evaluará según la participación, desempeño en la actividad y calidad en las respuestas

Tarea

Realizar el sonido del motor del carro.

Comentar en la casa la actividad que se realizó en el gabinete.

Repetir varias veces: Fiesta, feliz, foto, fácil, fecha.

Traer una foto de la familia.

¡Hasta la próxima clase!

Tratamiento #8

Eje temático: Las frutas

Objetivo: Articular el fonema /r/ mediante palabras y oraciones, con énfasis en el desarrollo lingüístico y cognitivo.

Método: Explicación

Procedimientos: Imitación y control visual.

Medios de enseñanza: espejo, voz del maestro, láminas, software educativo.

Material verbal: frutas, naranja, jugo, mandarina, rojo, plátano, pera, arboles, sabroso, refrescante.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

Revisar la tarea del encuentro anterior. Ver las imágenes que trajo el educando y preguntar cuáles son sus alimentos favoritos.

Presentar la siguiente adivinanza acompañada de una lámina de frutas.

Se puede comer y tomar

para refrescar,

de diferentes sabores

las podemos encontrar.

(las frutas)

¿Te gustan las frutas? ¿Cuáles te gustan más?

Análisis fónico de la palabra frutas.

¿En qué sílaba se encuentra el sonido /r/? Circula las palabras que presentan la letra r

plátano pera manzana mandarina melón piña
melocotón

Ir frente al espejo y realizar los ejercicios de vibración bilabial más vocal en series de a tres

-----á	-----á	-----á
-----é	-----é	-----é
-----i	-----í	-----í
-----ó	-----ó	-----ó
-----ú	-----ú	-----ú

Vamos a colorear las siguientes frutas.¿Qué color usarías para colorear el plátano?

Llevar frutas reales para que el educando las observe y vea sus características.

Realizar el siguiente ejercicio frente al espejo.

aráaráará eré eréeréiríirí oró oróoró urú urúurú

Menciona palabras que presenten el sonido r.

Conclusiones Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado.

¿De qué hablamos hoy en el tratamiento?

¿Crees que es importante comer frutas? ¿Por qué?

Evaluación

¿Cómo trabajaste hoy?

El logopeda evaluará según la participación, desempeño en la actividad y calidad en las respuestas.

Tarea

Pronuncia correctamente las siguientes palabras: rosa, radio, ratón, reloj, rubio.

Tratamiento #9

Eje temático: Las acciones

Objetivo: Pronunciar en palabras y oraciones el fonema /r/, con énfasis en la percepción fonemática y el desarrollo cognitivo.

Método: Explicativo

Procedimientos: Imitación y control visual.

Medios de enseñanza: láminas, tarjetas, espejo.

Material verbal: caminar, cepillar, limpiar, levantar, comer.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

Observa las siguientes tarjetas y ordena según ocurren de forma lógica.

Los niños se levantan de la cama y van al baño para lavar la cara y cepillar sus dientes. Luego se ponen el uniforme para ir a desayunar. ¿Qué comen los niños? Los niños comen pan y leche. Su mamá los despide y ellos caminan hacia la escuela.

Levantar, cepillar, comer, caminar, son algunas de las acciones que realizamos diariamente. Son acciones porque indican lo que hacemos en un momento determinado.

Identifica que acciones realizan estas personas.

Mostrar láminas que indiquen las siguientes acciones: jugar, saltar, leer, cantar, etcétera.

Ir frente al espejo y realizar los ejercicios de vibración bilabial en series de a tres y posteriormente pronunciar:

arararererer ir irirorororururur

Escribe tres oraciones con algunas de las palabras anteriores.

Conclusiones: Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado.

Evaluación

¿Cómo trabajaste hoy?

El logopeda evaluará según la participación, desempeño en la actividad y calidad en las respuestas.

Tarea

Realiza en tu casa gárgaras. Pide ayuda a tus padres.

¡Hasta la próxima clase!

Tratamiento #10

Eje temático: La familia.

Objetivo: Identificar los miembros de la familia y pronunciar palabras con los sonidos/g / y /r/.

Método: Explicación.

Procedimientos: Observación, pronunciación enfatizada, descripción.

Medios de enseñanza: Espejo, fotos de la familia, lámina, tarjetas.

Material verbal: familia, papá, mamá, hermanos, abuelitos, tíos, primos, reloj, rojo, rosado, radio, ríen.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

Presentar láminas. Di qué observas y qué hacen.

¿Conoces los miembros de la familia? Nómbralos.

¿Con quiénes tú vives?

Pedir que muestre las fotos que trajo de su familia y di el parentesco que tiene contigo.

Presentar tarjetas. Fíjate en la figura, nombra y describe lo que observas.

Elabora una oración donde te refieras a un miembro de la familia.

Piensa, responde y pronuncia correctamente: ¿Qué se pone papá en la mano para ver la hora? R/ El reloj.

Las abuelitas escuchan las novelas con el... R/ Radio

¿Qué hacemos cuando nos vamos a tirar una foto? R/ Reímos

¿De qué color es la blusa de la niña de la tarjeta? R/ Roja

¿De qué color es el vestido de la abuela? R/ Rosado

Insistir en la correcta pronunciación de las siguientes palabras: reloj, rojo, rosado, ríen, radio.

Invitar al niño a ir frente al espejo.

El logopeda mostrará la posición articulatoria del fonema y pedir al niño que aprecie, mediante la percepción táctil, la presencia de vibraciones laríngeas.

Cuando tenemos la garganta enferma mamá nos pone a hacer gárgaras. Imaginemos que estamos haciendo gárgaras. Gggggggggggg

Presentar lámina. Observa y responde.

¿Qué observas?

¿Quiénes están abrazados a la derecha?

¿Quiénes están sentados a la izquierda?

¿Dónde están sentados?

¿Qué tiene el abuelo en la mano derecha?

¿Quiénes están delante?

¿Cómo está vestido el niño?

¿Qué es lo que está detrás de la familia?

¿De qué color son la pared y el piso?

¿Cómo crees que sean las relaciones de esta familia? ¿Por qué?

Conclusiones Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado.

¿De qué hablamos hoy en el tratamiento?

Menciona los miembros de la familia.

Menciona las palabras con /r/ que recuerdes.

Realiza el ejercicio frente al espejo.

Evaluación

¿Cómo trabajaste hoy?

El logopeda evaluará según la participación, desempeño en la actividad y calidad en las respuestas.

Tarea

Realiza gárgaras frente al espejo.

Pronuncia correctamente las siguientes palabras: rosa, radio, ratón, reloj, rubio.

¿Pregunta a tus familiares que labores realizan en la casa y en cuáles tú puedes ayudar o realizar?

El sistema de tratamientos logopédicos propuesto en esta investigación fundamenta su trabajo teórico-metodológico en la concepción dialéctico-materialista del mundo. Esta concepción permite ver al ser humano desde una visión holística formado y desarrollado histórica y socialmente, por tanto, es una premisa fundamental para comprender las relaciones sociales. El vínculo de los principios, leyes y categorías filosóficas permite establecer relaciones del fenómeno objeto de estudio. A partir del análisis objetivo-subjetivo de la problemática se puede arribar a un diagnóstico explicativo y diferencial con carácter sistémico, conocer el origen y las causas de la situación existente en el lenguaje que influye en el aprendizaje y en el desarrollo íntegro de la personalidad. La aproximación a los ejercicios y actividades logopédicas influyen en la transformación de los cambios cualitativos en cuantitativos y viceversa. El maestro logopeda actúa como mediador ante las actividades que propone con la familia y con otros maestros. Se revela la unidad entre la psiquis, la actividad y la comunicación, por ser en la actividad y por medio de la comunicación con los otros, donde se adquieren los aprendizajes en la vida. La interacción que se establece entre escolar-familia-logopeda-maestro propicia la unidad de lo afectivo- cognitivo para el desarrollo de los procesos psíquicos superiores. En este sentido, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural revela la importancia del contexto donde tiene lugar el proceso de desarrollo del lenguaje; es por ello la orientación a la familia hacia la correcta articulación de los sonidos y la correcta comunicación para la vida en sociedad. El enfoque histórico cultural de Vigotsky va orientado hacia el desarrollo psicológico de

todo individuo; tiene su origen en la acumulación de vivencias, ve al hombre como un ser biopsicosocial. Los contenidos que se abordan ayudan al educando a ampliar sus vivencias. La profundización en el estudio de las causas biológicas es fundamental en la elaboración de la estrategia. Se tienen en cuenta las características para la asimilación de los contenidos. Su reacción ante estímulos es más lenta que en otros niños, por tanto, las actividades son flexibles en cuanto a tiempo de duración. La comunicación depende en gran medida de la influencia de factores sociales. La familia debe ser un modelo lingüístico y comunicativo para el escolar y los agentes sociales contribuyen en esa transformación positiva. Desde el punto de vista educativo la dinámica seleccionada está en correspondencia con los fines de la educación y se destaca el carácter humanista de la educación cubana en la formación de un hombre integral. Las actividades responden a las necesidades del niño y tienen en cuenta sus potencialidades, además no se limitan a la escuela, se implica a la familia, la comunidad y la sociedad. Se utilizan videos, softwares educativos, canciones infantiles, láminas y otros recursos que permiten la motivación. La metodología a utilizar en la organización y diseño del sistema de tratamientos conlleva a la distribución del tiempo, los métodos y procedimientos, los medios de enseñanza, material verbal y sobre todo los ejes temáticos para ampliar el vocabulario activo y pasivo. El escolar al ser valorado influye en su conducta y la misma se modifica para el próximo tratamiento. Se utilizan los procedimientos logopédicos y los psicoterapéuticos, tales como: las dramatizaciones, la rítmica logopédica, los diálogos, las narraciones, etcétera. Otras condiciones necesarias son la aplicación de técnicas logopédicas de instauración, automatización y consolidación de los fonemas mediante la rítmica logopédica. Se puede trabajar con la familia en el gabinete alguna de las actividades y el maestro también puede participar en este proceso. La frecuencia de cada tratamiento varía en dependencia de la cantidad de sonidos afectados, de la forma en que estos se afectan y de la evolución del escolar ante los ejercicios. La duración de cada tratamiento es de 15 a 20 minutos. Lo anteriormente fundamenta el carácter científico de esta investigación y la interdisciplinariedad de las actividades propuestas.

La aplicación de este sistema de tratamientos arrojó resultados positivos en la práctica. El escolar desarrolló habilidades comunicativas y cognoscitivas para el cumplimiento de los objetivos del grado. El trabajo con las líneas discontinuas permitió al escolar el control de la motricidad fina para la asimilación del código de la lectoescritura, las actividades manuales que se presentan contribuyeron en la ejercitación de la atención y en la creatividad del educando. La categoría de evaluación logopédica alcanzada fue de ligeramente superado por la corrección y compensación de algunos fonemas afectados; sin embargo, se debe dar orientación y seguimiento en el próximo curso. Se comprueba, una vez más, el papel tan importante que juega la familia en la educación de sus hijos. La familia se sintió motivada por la labor que realizó el centro y la unidad de los maestros para influir en la personalidad del educando.

Conclusiones

Después de analizar los referentes teórico-metodológicos se pudieron constatar autores del contexto internacional y nacional que constituyen antecedentes de la investigación. Los conceptos que se asumen están en correspondencia con la concepción de la educación especial en Cuba y poseen actualidad. El estudio de caso que se propone refleja las condiciones de la vida familiar y escolar del educando.

La estrategia de atención logopédica es una alternativa a utilizar por los maestros para la atención a niños con retraso del lenguaje y las actividades que se presentan estimulan el lenguaje oral y escrito. También va dirigida a niños con diagnóstico de retardo en el desarrollo psíquico y favorece el interés entre los miembros de la familia y la escuela para el desarrollo integral de la personalidad.

Recomendaciones

- Profundizar en el estudio del caso seleccionado, para ahondar en los fundamentos teóricos y metodológicos.
- Crear actividades que se deriven de las diferentes técnicas pedagógicas y psicológicas aplicadas, que permitan el desarrollo de la comunicación y el lenguaje del menor.
- Comprobar en la práctica pedagógica con la aplicación de nuevas técnicas, el desarrollo del menor seleccionado.

Bibliografía

ARIAS, G. LLORENS, V.D. La educación especial en Cuba. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1998

ÁLVAREZ L, FERNÁNDEZ L, FERRER A, LÓPEZ M, SARDIÑAS A, CASTELLANO G, ET AL. Manual de técnicas logofoniatricas. Soporte digital. La Habana, Cuba; 2006.

DUBÉ Y. Estudio de caso. La Habana, Cuba: Facultad de Educación Infantil, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”; 2011

FERNÁNDEZ G. La atención logopédica en la edad infantil. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 2008.

FERNÁNDEZ I L, VÁZQUEZ G. Recursos tecnológicos para el tratamiento logopédico. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 2008.

FIGUEREDO E, LÓPEZ M. Logopedia I. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 1984.

FIGUEREDO E, LÓPEZ M. Logopedia II. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 1986.

GARCÍA PÉREZ, E.M. ¡Soy Hiperactivo! ¿Qué puedo hacer? Bilbao: Grupo ALBOR-COHS, 1997.

HERNÁNDEZ Y. Estudio de caso. La Habana, Cuba: Facultad de Educación Infantil, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”; 2011.

LEVINA R E, KASCHE G A, ET AL. Sobre algunos temas del trabajo logopédico. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba; 1983.

MESA P, ET AL. El trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 2006.